

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 첨언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

5장 체간부 추나치료

장골 교정기법

복와위 장골 전방회전 교정기법

1) 적응증: 장골 전방회전변위

→ 전방회전변위는 다리를 내려야 하는데 다리를 내릴 수 없기 때문에 좌골을 더 눌러줌

2) 금기증: 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

3) 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 전방회전변위된 장골의 환측면에 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 변위된 장골의 좌골결절에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수는 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 교정의 방향: 후방에서 전방으로 약간 족방에서 두방으로 교정한다.

4) 치료절차

- 환자는 복와위를 취하고 의사는 환자의 전방회전변위된 환측면에 서서
- 주동수의 두상골부를 환자의 좌골결절에 접촉시키고 보조수로는 주동수의 손목을 잡아 지지한다.
- 저항가동점까지 이동 후에 후방에서 전방으로 짧게 누른다.
- 이때 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간교정해도 좋다.



- 전방회전된 경우 좌골결절에, 후방회전된 경우 좌골결절, 후상장골극에 접촉한다.
- 전방회전 되어있기 때문에 좌골결절이 당연히 튀어나오는데, 이렇게 튀어나온 부분을 밀어서 없애준다고 생각하기 (그래서 후방에서 전방으로 밀기)
- 주동수는 편한손으로 하고, 환자가 긴장하거나 안 좋은 상태에서 교정하면 다칠 수 있음
- 환자가 호기할 때 충분히 이완된 상태에서 제한장벽까지 가서 마지막에 툭 눌러줘야 함 (팔 힘보다는 체중을 이용)

복와위 장골후방회전/천골측굴 교정기법

1) 적응증: 족지장단분석에서 장골 후방회전/천골 측굴변위로 진단된 경우

2) 금기증: 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

3) 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 환자의 환측면에 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 변위된 장골의 1단계에선 좌골결절, 2단계에선 후상장골극에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수는 1단계에서는 주동수의 손목을 잡고 주동수를 지지하며, 2단계에서는 하퇴의 슬관절 전면 상부를 감싸 들어올린다.
- 교정의 방향: 1단계의 경우 족방에서 두방으로, 후방에서 전방으로 교정하고, 2단계의 경우 후방에서 전방으로 교정한다.

④ 치료절차

<1단계> 뒤로 돌아 아래로 내려간 것을 밀어서 올려주는 역할



A. 1단계

- 환자는 복와위를 취하고 의사는 환자의 장골 후방회전/천골 측굴변위된 환측면에 서서
- 주동수의 두상골부로 환자의 변위된 장골의 좌골결절에 접촉하고
- 보조수로 주동수의 손목을 잡고 지지한다.
- 족방에서 두방으로, 후방에서 전방으로 저항가동점까지 이동 후 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간 교정한다.

→ 복와위 상태에서 좌골결절을 뒤에서 앞으로 밀어주기 (=후방회전 된 것을 앞으로 보내기 위함)

→ 좌골결절에 접촉하여 족방에서 두방쪽으로 캔 따듯이 밀어주기. 숨을 들이 쉬고 내릴 때 밀어줌

→ 선생님들도 왜 1단계를 시행해야하는지 의문이 있었음. 이 기법에서 <2단계>가 더 중요해보임

<2단계> 들어 올리고 앞으로 회전시킨 상태에서 밀어서 올려주는 역할



B. 2단계

- 환자는 계속 복와위를 유지하며 의사는 1단계보다 환자의 두방으로 이동하여 환측면에 선다.
- 두방수의 두상골부로 변위된 장골의 후상장골극을 접촉하고
- 보조수로 환자의 하퇴 슬관절 전면을 감싸 들어올린 후 → 다리를 들어 회전을 더 만듦
- 저항가동점에서 추나 테이블의 낙차를 이용하여 순간교정한다.
 - 후방회전되었기 때문에 후상장골극에 tissue pull 한 다음 슬관절을 들어올림
 - 슬관절을 들어 올릴 때 처음에는 무릎만 든다고 느껴지는데 조금 더 들어올리면 장골이 같이 들리는 느낌이 듦
 - 이 상태에서 숨을 들이마쉬고 내릴 때 낙차를 이용해서 누름

측와위 장골 교정기법

1) 적응증: 장골 후방회전변위와 전방회전변위, 인플레어와 아웃플레어

2) 금기증: 급성 요부 염좌, 퇴행성 척추 질환에는 신중

3) 치료

- 환자의 자세: 측와위
 - 후방회전변위가 일어난 쪽을 위로 향하여 측와위 자세 → 시술하는 쪽을 위로 가게 함
 - 환자의 아래쪽 어깨는 전방으로 위쪽 어깨는 후방으로 위치시키고 환자의 팔은 서로 깎지 낀 상태로 체간의 측면에 위치- 환자의 아래쪽 다리는 적당한 굴곡을 주어 위치시키고 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래 다리의 오금에 건다. 골반의 위치를 추나치료 테이블의 모서리에 둔다.
- 의사의 자세: 환자의 정면 방향에 펜싱 자세로 두방을 향해 선다. 족방 슬부 및 대퇴부는 환자의 위쪽 다리의 슬부나 대퇴부에 접촉한다. 족방의 다리는 바닥에서 댄다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 두상골부로 후방회전변위의 경우 환자의 환측 후상장골극에 접촉시키고 전방회전변위의 경우 환자의 환측 좌골결절에 접촉한다. 손가락은 척추를 가로질러 비스듬히 두방과 중앙을 향하고, 상박은 접촉수에 직각을 유지한다.
- 시술방법: 의사는 주동수, 보조수, 대퇴부로 몸의 이완을 제거한다. 보조수는 두방으로 밀면서 상부 체간을 고정시키고 주동수로는 치료방향을 따라 밀다가 동시에 체중을 실어 저항가동점에서 전면으로 순간교정한다. 추나치료 테이블의 낙차를 이용해도 좋다.
- 교정의방향
 - 주동수로는 후방회전변위의 경우 후방에서 전방으로, 하방에서 상방으로,
 - 전방회전변위의 경우 후방에서 전방으로, 상방에서 하방으로
 - 인플레어의 경우 외측방에서 내측방으로 회전력을 주고
 - 아웃플레어의 경우 내측방에서 외측방으로 회전력을 준다.
 - 두방수는 환자의 전방에서 후방으로 약간 족방에서 두방으로 어깨를 민다.



A. 후방회전



B. 전방회전

- 시연만 하고 기법 시행 X

- 교정의 방향이 중요 → 변위를 보고 생각

- 11주차에 배운 측와위 요추 중립성기능부전 교정기법이 대각선 방향으로 힘을 줬다면, 이거는 아예 걸레 짜듯이 전후로 비트는 기법으로 자극량이 매우 강함 (급성 요부 염좌가 있는 상태에서 무리하게 기법 시행 시 통증이 매우 심함)

천골 교정기법

복와위 천골 측굴회전변위 교정기법

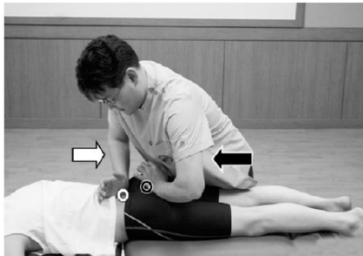
1) 적응증: 천골의 좌측굴 우회전/우측굴 좌회전 변위

2) 금기증: 급성 염좌는 상대적 금기, 골절은 절대적 금기

3) 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 의사는 변위된 천골기저부의 환측면에 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 두방수. 주동수의 두상골부로 천골이 하방된 쪽의 반대측 후상장골극의 내측에 접촉한다.
- 보조수: 족방수. 보조수의 두상골부로 천골이 하방된 반대측의 천골절흔에 접촉한다.
- 교정의 방향: 주동수는 내측에서 외측으로, 보조수는 외측에서 내측으로 교정한다.

4) 치료절차



- 환자는 복와위 상태에서 의사는 변위된 천골기저부의 환측면에 서서
- 주동수의 두상골부로 천골이 하방된 쪽의 반대측 후상장골극의 내측에 접촉하고,
- 보조수의 두상골부로 천골이 하방된 반대측의 천골절흔에 접촉 후
- 교차시키듯 주동수는 내측에서 외측으로, 보조수는 외측에서 내측으로
- 저항가동점까지 이동 후에 순간교정하거나 추나치료 테이블의 낙차를 이용해서 치료한다.

- 천골의 우측굴 좌회전 변위

- 천골은 장골안에 파묻혀서 천골만 움직이기는 불가능하기 때문에 골반 전체를 움직임

- 검사법에서 잘 안 움직이고 덜 올라오는 쪽이 측굴되었다고 본다.

→ 회전변위는 체중에 의해 저절로 보상됨

5) 검사법

- 이 치료를 하기 전에 환자를 복와위로 눕히고 천골에 손바닥을 대고 누른 상태에서
- 환자에게 양쪽 다리를 차례로 무릎을 편 상태로 들어보게 하는 것
- 이때 적게 올라가는 쪽의 천골과 장골이 맞물린 것이므로 해당 천골이 측굴 변위된 것으로 추측

→ 다리가 높이 안 들어지는 쪽이 측굴변위가 일어남 (좌측굴 변위면 천골이 왼쪽으로 기울어짐)



측와위 천골 교정기법

→ 천골에 정확하게 힘을 전달하기 어려워 복와위 위주로 진행 (기법 안 함)

치골 신연기법

양와위 치골 신연기법

1) 적응증: 치골 기능부전

2) 금기증: 만성적인 구축상태에서는 시술시 주의를 요함

3) 치료

- 환자의 자세: 양와위를 취하고 양쪽 고관절과 슬관절을 굴곡시키고 두 발을 바닥에 나란히 붙인다.
- 의사의 자세: 테이블의 족부쪽에서 환자를 향해서 선다.
- 주동수: 수장부로 무릎 내측면에 접촉한다.
- 보조수: 주동수와 동일
- 교정의 방향: 내방에서 외방으로 신연시킨다.

4) 치료절차



- 전완을 교차시킨 채로 무릎의 내측면에 접촉하여
- 환자에게 약 5초간 혹은 내전근의 피로가 충분히 유발될 때까지 무릎을 내전시키도록 지시 하면서 반대의 방향으로 저항을 준다.
 - 처음부터 강하게 하면 치골쪽이 찢어지듯 아프기 때문에 조금씩 힘을 주고 점점 나아지면 강하게 시행 (첨언) 다리 힘이 너무 강해서 버티기 어렵다면 팔꿈치를 다리 사이에 넣고 지지하면서 시행